

03. MISE EN PLACE DU MESODERME ET LA NOTOCHORDE

DURÉE : 03:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous guide à travers le processus fascinant de la mise en place du mésoderme et du rôle crucial de la notochorde dans le développement embryonnaire. Vous apprendrez comment ces structures interagissent au niveau cellulaire, notamment grâce à la ligne primitive et aux cellules en bouteille, entraînant la formation du tissu mésenchymateux primitif. De plus, vous explorerez des aspects pratiques en lien avec le coccyx, en découvrant comment les impulsions et les champs électromagnétiques influencent la santé des tissus. La session inclut une approche pratique des mouvements notochordaux tout en mettant en lumière l'interconnexion entre le sacrum, le coccyx, et même le cœur, approfondissant ainsi votre compréhension de l'embryologie biodynamique et de l'ostéopathie.

MISE EN PLACE DU MÉSODERME ET DE LA NOTOCHORDE

LA MISE EN PLACE DU MÉSODERME

La première étape cruciale est la **mise en place du mésoderme**. On observe l'apparition de la **ligne primitive** et de l'**axe notochordal**.

Il existe un champ d'aspiration entre le tissu **ectodermique** et le tissu **endodermique**, créant un mouvement où un espace va se combler.

Le tissu mésodermique a pour origine le tissu **épiblastique**, et non le tissu ectodermique. Les **cellules en bouteille** sont attirées vers le centre.

C'est ainsi que l'espace entre le tissu épiblastique et hypoblastique devient le **tissu mésenchymateux primitif**, futur mésoderme.

RÔLE DE LA NOTOCHORDE

La **notochorde** influence ce processus. C'est un champ électrique qui agit.

Lors du cours précédent, nous avons travaillé au niveau du **sacrum**, en nous concentrant sur l'axe notochordal.

Nous allons explorer le processus plus en profondeur. La notochorde, positionnée ici, est liée au **nœud d'Hensen**.

Cela génère un mouvement de vague, un mouvement **crânio-caudal**, où la ligne primitive régresse progressivement vers l'arrière.

Cette ligne primitive se retrouve au niveau de la base **sacro-coccygienne**, constituant un vestige énergétique.

On observe ainsi la mise en place du mésoderme.

LA PRATIQUE : LE COCCYX ET LES IMPULSIONS

Nous allons pratiquer en nous concentrant sur le **coccyx**, car cette zone concentre l'énergie.

La première impulsion se produit sur le tissu **hypoblastique**. C'est à ce moment que l'épiblaste devient **ectoderme** et l'hypoblaste devient **endoderme**.

Cela signifie que l'épiblaste informe tous mes tissus, et il est lui-même complètement intégré par ma notochorde. C'est un champ **électromagnétique** qui informe le corps.

Lorsque nous touchons consciemment ce niveau, nous sommes connectés à cette force que le corps a mise en place.

DÉVELOPPEMENT DU TISSU MÉSODERMIQUE

Nous arrivons à la deuxième impulsion, la deuxième vague, qui va former le **tissu mésodermique**.

J'obtiens ainsi une information initiale notochordale qui, avec ma ligne primitive, génère ce champ d'aspiration.

Ce dernier crée l'espace de ma ligne primitive, en contact avec la mise en place de mon **pédicule embryonnaire** et mes champs de **perméation** et d'**infusion** qui s'organisent.

C'est dans ce mouvement que s'opère l'intégration de mon mésoderme. Ceci se passe entre le **quatorzième** et le **seizième jour**.

Quand vous pratiquez, vous percevez d'abord cette sorte de **"Tai Chi"**, cette vague notochordale.

Puis, en dessous, en même temps que ce mouvement, il y a une invasion en dessous. C'est un **double mouvement**.

On peut se positionner sur le sacrum ou sur le coccyx. Par la suite, nous aborderons d'autres points d'équilibre très spécifiques au niveau du **cœur**.

L'aspect présomptif du cœur est déterminé par ce champ d'action.

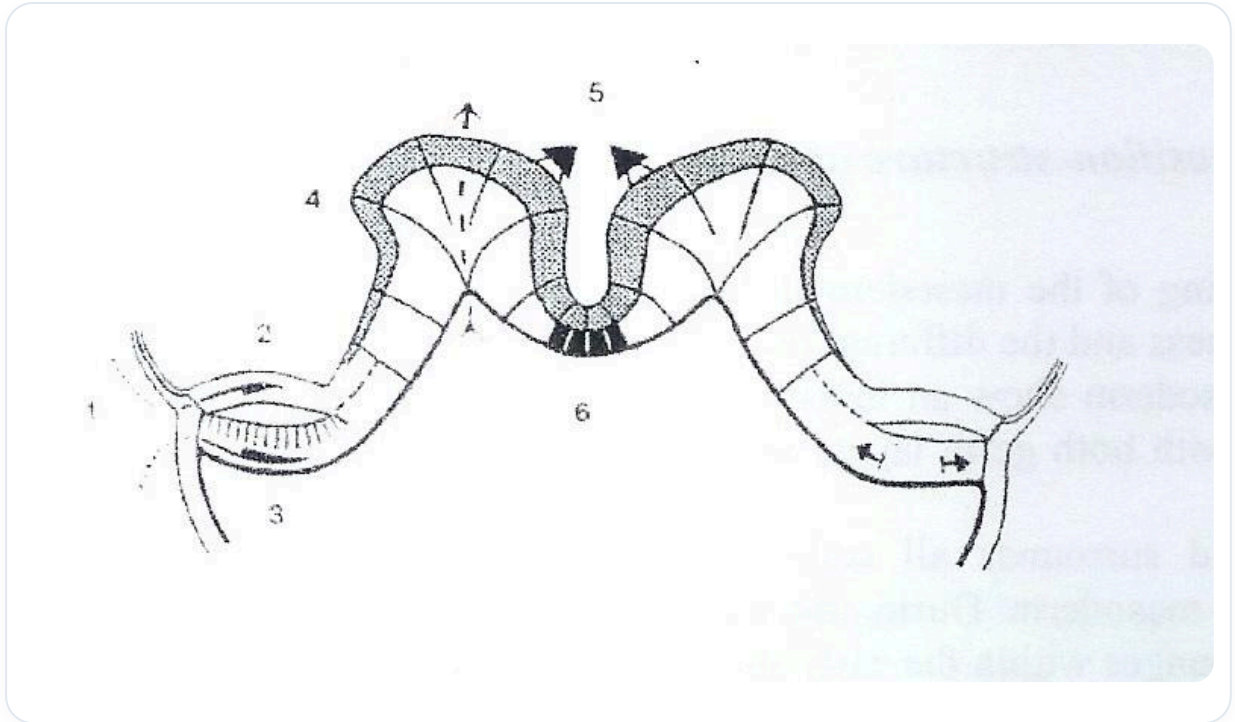


FIG. — Début neurulation

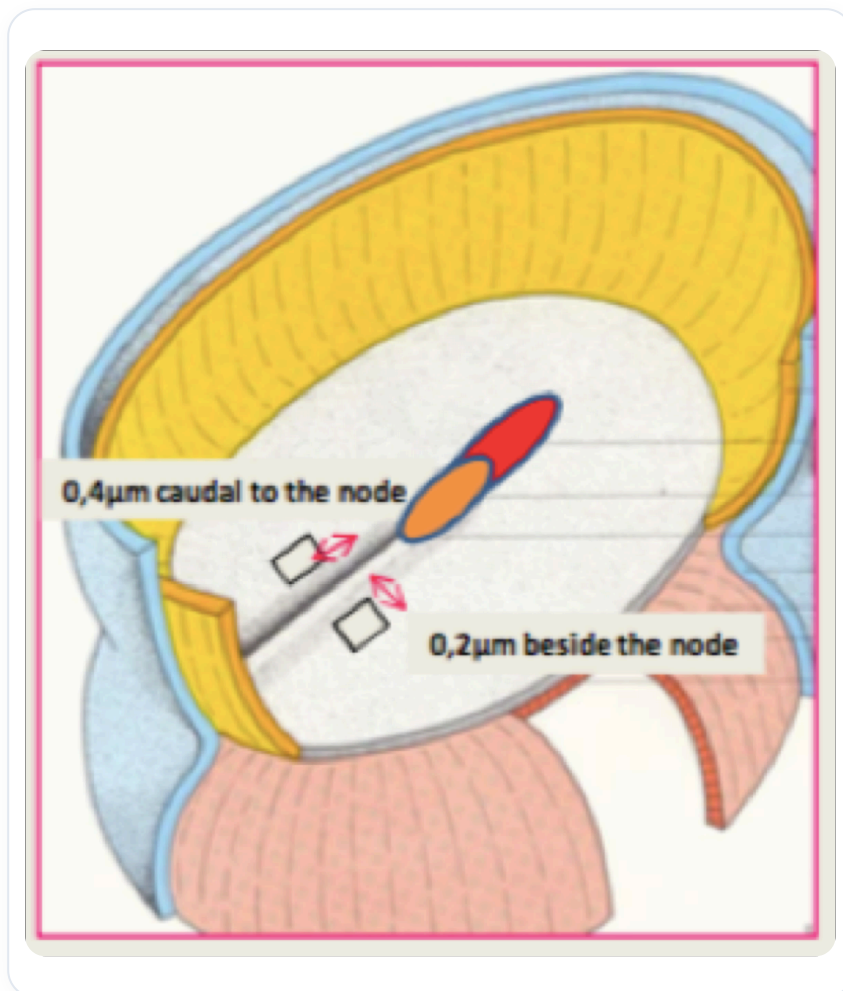


FIG. — Développement embryonnaire précoce

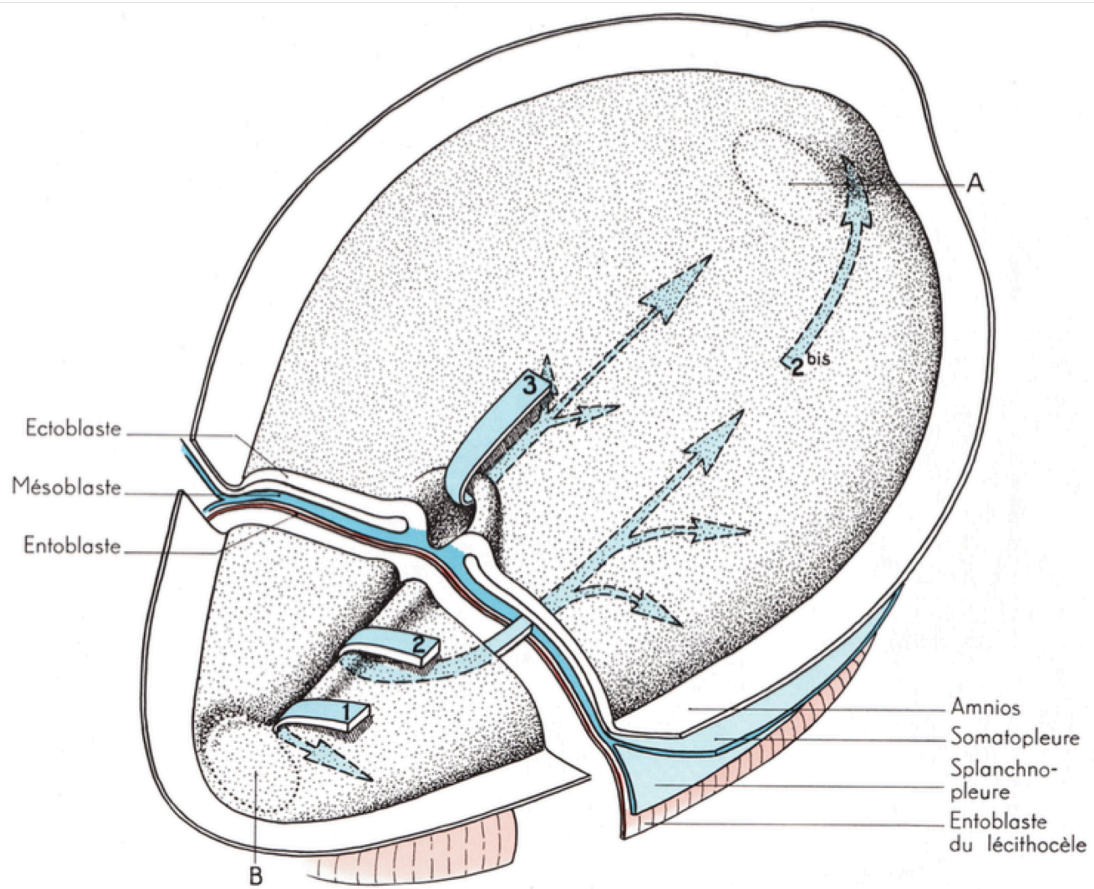
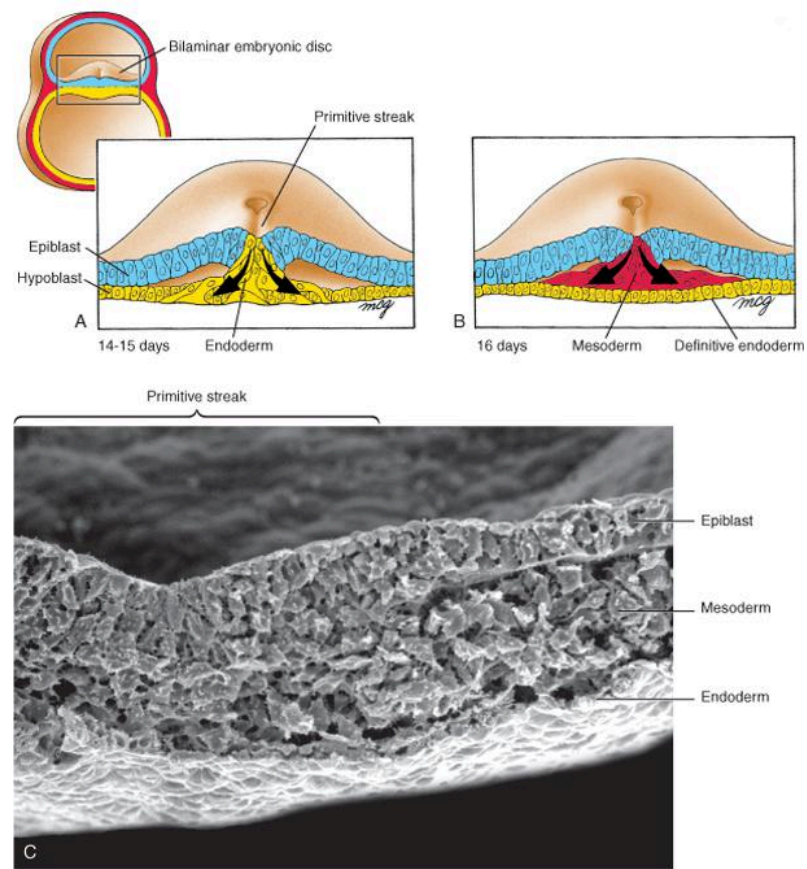


FIG. — Gastrulation humaine 3 semaines



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — *Gastrulation humaine*



- Amnios
- Somatopleure
- Splanchnopleure
- Entoblaste du lécithocèle



FIG. — Migration mésoenchymateuse

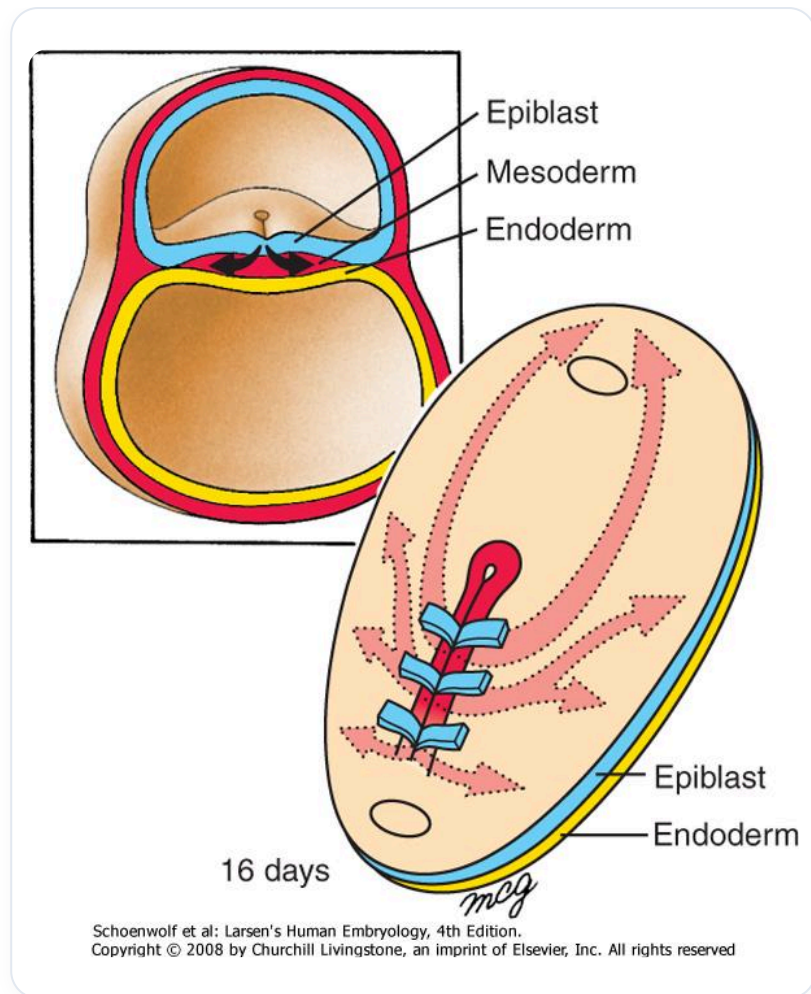


FIG. — Gastrulation 16 jours